

TEMA 8.8 • NEUROLOGÍA Y GERIATRÍA

ELA y Esclerosis Múltiple

PERFIL EUNACOM 1.10.2.005

Dx: Específico • Tx: Completo • Seg: Completo

Epilepsia, Convulsiones Febriles y Estatus Convulsivo

Clasificación de Crisis Convulsivas

TABLA 8.8.1: TIPO VS SUBTIPOS	
TIPO	SUBTIPOS
Focal	Parcial simple (sin pérdida de conciencia)
	Parcial compleja (con pérdida de conciencia)
	Focal → generalizada secundaria
Generalizada	Tónico-clónica
	Tónica, atónica, mioclónica, ausencia

EUNACOM CRITERIOS

Si empieza **focal** → siempre se clasifica como FOCAL, aunque luego generalice.

Diagnóstico y Manejo según Tipo

TABLA 8.8.2: TIPO VS ESTUDIO		
TIPO	ESTUDIO	ANTICONVULSIVANTES
Focal	RNM o TAC con contraste (buscar lesión)	Fenitoína / carbamazepina
Generalizada	Exámenes generales + EEG	Ácido valproico / lamotrigina
Tónico-clónica generalizada	EEG	Fenitoína

Diagnóstico de epilepsia

- **2 crisis iguales** sin causa explicada → epilepsia
- **1 crisis + EEG alterado** → epilepsia
- **1 sola crisis** → primoconvulsión → descartar causa metabólica → esperar segunda crisis o EEG

Convulsiones Febriles (Pediatría)

- **Rango:** 5 meses – 6 años

TABLA 8.8.3: SITUACIÓN VS CONDUCTA	
SITUACIÓN	CONDUCTA
Benigna, primera vez	Solo paracetamol + educar
Recurrente (30% de los casos)	Paracetamol + diazepam VO si hace fiebre
Convulsionando ahora	Lorazepam 0,1 mg/kg EV (niños) / 4 mg EV (adultos)
Aspecto tóxico + signos meníngeos	TAC → Punción lumbar → descartar meningitis
CF compleja (focal, > 15 min, ≥ 2 en 24h)	RNM

CF compleja: cualquiera de estas 3

- Crisis **focal** (no generalizada)
- Duración > **15 minutos**
- ≥ **2 crisis** en 24 horas

Estatus Convulsivo

- **Definición:** convulsión ≥ 30 min sin recuperación entre crisis
- **Regla clave:** ¡No esperar los 30 minutos para actuar!

Tratamiento Escalonado

- **Lorazepam 4 mg EV** (adulto) / **0,1 mg/kg** (niño) + **carga de fenitoína** (previene recaída)
- Si falla → **Fenobarbital**
- Si falla → **Pentobarbital o propofol** (anestesia general)

CASO CLÍNICO TIPO EUNACOM

ESCENARIO CLÍNICO TÍPICO:

"Paciente de 55 años consulta por debilidad progresiva de 8 meses de evolución. Al examen presenta hiperreflexia en extremidades superiores, fasciculaciones en extremidades inferiores y atrofia muscular generalizada. No presenta alteraciones sensitivas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?"

EXPLICACIÓN CLÍNICA DETALLADA:

Manejo clínico y diagnóstico según normativa MINSAL y perfil EUNACOM para ELA y Esclerosis Múltiple. Priorizar reconocimiento precoz y tratamiento de primera línea.

PUNTOS CLAVE DESTACADOS

- ELA: enfermedad degenerativa del asta anterior de la médula. Clínica **EXCLUSIVAMENTE** motora, mezcla de primera y segunda motoneurona, progresiva. Pronóstico muy malo (3-5 años).
- ELA clásica: hipertonía + hiperreflexia (1era motoneurona) + atrofia + fasciculaciones (2da motoneurona). Diagnóstico absolutamente clínico, sin tratamiento curativo.
- Primera motoneurona (piramidal): hipertonía, hiperreflexia, clonus, Babinski. Segunda motoneurona (denervación): hipotonía, hiporreflexia, fasciculaciones, atrofia marcada.
- Esclerosis Múltiple: autoinmune, desmielinización del SNC (cerebro, tronco, médula, cerebelo, nervio óptico). Afecta sustancia blanca.
- EM vs AVE: signos focales que aparecen de a poco (horas-días), no súbitos.
- Diagnóstico de EM: RM nuclear (confirma focos de desmielinización). PL: aumento oligoclonal de Ig (apoyo).
- Tratamiento EM: crisis = corticoides EV. Inter crisis = interferón (patología AUGE).
- Neuritis óptica es característica de la EM. Guillain-Barré desmieliniza SNP, EM desmieliniza SNC.

EVALUACIÓN DE CLASE Y PREGUNTAS TIPO EUNACOM (ELA Y ESCLEROSIS MÚLTIPLE)**PREGUNTA 1**

Paciente de 55 años consulta por debilidad progresiva de 8 meses de evolución. Al examen presenta hiperreflexia en extremidades superiores, fasciculaciones en extremidades inferiores y atrofia muscular generalizada. No presenta alteraciones sensitivas. ¿Cuál es el diagnóstico más probable?

- A)** Esclerosis Múltiple
- B)** Esclerosis Lateral Amiotrófica
- C)** Síndrome de Guillain-Barré
- D)** Polineuropatía diabética
- E)** Miastenia gravis

PREGUNTA 2

Mujer de 30 años presenta pérdida de agudeza visual del ojo izquierdo que se instaló en 3 días, asociada a debilidad en extremidad inferior derecha progresiva. ¿Cuál es el estudio diagnóstico de elección?

- A)** TAC de cerebro sin contraste
- B)** Electroencefalograma
- C)** Resonancia magnética nuclear
- D)** Punción lumbar
- E)** Electromiografía

PREGUNTA 3

Paciente con diagnóstico de Esclerosis Múltiple presenta una nueva crisis con hemiparesia derecha progresiva. ¿Cuál es el tratamiento de la crisis?

- A)** Interferón subcutáneo
- B)** Corticoides endovenosos
- C)** Plasmaféresis
- D)** Inmunoglobulina G endovenosa
- E)** Carbamazepina

RESUMEN: ELA Y ESCLEROSIS MÚLTIPLE

Esta clase aborda dos enfermedades neurológicas importantes: la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) y la Esclerosis Múltiple (EM), siendo esta última patología AUGE. La ELA es una enfermedad degenerativa del asta anterior de la médula donde hacen sinapsis la primera y segunda motoneurona. Su pronóstico es muy malo (3-5 años de sobrevida). La clínica es exclusivamente motora (sin síntomas sensitivos), con mezcla de primera motoneurona (hipertonía, hiperreflexia, clonus, Babinski) y segunda motoneurona (hipotonía, hiporreflexia, fasciculaciones, atrofia marcada). La presentación clásica incluye hipertonía, hiperreflexia, atrofia y fasciculaciones. El diagnóstico es absolutamente clínico. No existe tratamiento curativo, solo soporte. La Esclerosis Múltiple es una enfermedad autoinmune con desmielinización del sistema nervioso central (cerebro, tronco encéfalo, médula, cerebelo y nervio óptico). Afecta la sustancia blanca. La clínica son signos focales que aparecen de a poco (no súbitos como el AVE), de instalación en horas a días. El diagnóstico se confirma con resonancia magnética nuclear. La punción lumbar puede mostrar aumento oligoclonal de inmunoglobulinas. La neuritis óptica es característica. El tratamiento de la crisis es con corticoides endovenosos, y la profilaxis intercrisis con interferón (cubierto por AUGE).